

1

# 肺癌:薬剤師の実践ポイント

## 個別化医療を支える服薬指導と連携

### 1 服薬指導で伝えるポイント



EGFR-TKI服用中の患者に、乾性咳嗽・息切れなど間質性肺疾患を疑う症状を具体的に伝える



ICI治療中は「いつもと違う症状」は些細でも申告するよう伝える(irAE)



血管新生阻害薬併用時は血圧の自己測定を習慣化してもらう

### 2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ EGFR-TKIとCYP3A4関連薬剤・制酸薬(胃内pH変化で吸収に影響)との相互作用を確認する
- ☐ 免疫チェックポイント阻害薬併用時、ステロイド全身投与歴が治療効果に影響しうる点に留意する
- ☐ 血管新生阻害薬使用者の手術予定・出血リスクの評価状況を確認する

### 3 施設間連携・情報共有のポイント



呼吸器症状出現時は、画像検査(CT等)につながる連携体制を確認しておく



バイオマーカー検査結果・治療ライン変更の経緯をお薬手帳等で共有する

### 4 実践チェックリスト

- ☐ 新規処方が分子標的薬・免疫療法・細胞障害性抗がん薬のいずれかを確認し、該当する重点モニタリング項目を意識する
- ☐ 咳嗽・呼吸困難の訴えは間質性肺疾患を念頭に早期の医療機関受診を案内する
- ☐ 治療ライン変更時は、新レジメンの副作用プロファイルを患者さんに改めて説明する

肺癌治療は薬剤の入れ替わりが多い。「今、何を使っているか」を毎回確認する姿勢が、副作用の見逃しを防ぐ。